

CAPÍTULO 13.39

Insuficiencia Venosa y Várices

PERFIL EUNACOM 1.02.1.019

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción

La **insuficiencia venosa crónica (IVC)** y las **várices** de extremidades inferiores constituyen una de las consultas más frecuentes en medicina general y cirugía vascular. Se define por la incapacidad de las venas para retornar la sangre adecuadamente hacia el corazón, lo que genera un aumento de la presión hidrostática venosa.

NOTA CLÍNICA

**Fisiopatología:** La IVC ocurre por la incompetencia de las válvulas venosas, la debilidad de la pared de la vena o la falla de la "bomba muscular" de la pantorrilla. Esto provoca reflujo sanguíneo y estasis, lo que a largo plazo daña los tejidos circundantes por extravasación de líquido y elementos formes.

Manifestaciones Clínicas

El diagnóstico de la insuficiencia venosa es fundamentalmente **clínico**. Los hallazgos típicos incluyen:

- **Várices:** Venas dilatadas, elongadas y tortuosas (habitualmente de las venas safenas y sus tributarias).
- **Telangiectasias:** Dilataciones de vénulas intradérmicas, de color violáceo o rojizo ("arañitas vasculares").
- **Edema:** Generalmente de tipo crónico. Puede ser simétrico o asimétrico.
- **Cambios tróficos:** La piel puede tornarse gruesa, indurada y de color oscuro (hiperpigmentación), cuadro conocido como **lipodermatoesclerosis**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta un **edema de instalación aguda y asimétrico**, es obligatorio descartar una **Trombosis Venosa Profunda (TVP)**, ya que representa una urgencia médica con riesgo de embolia pulmonar.

Diagnóstico Diferencial de Úlceras

Una de las complicaciones más graves de la IVC es la aparición de úlceras. Es vital distinguirlas de las úlceras arteriales para evitar manejos erróneos (como la compresión en una pierna isquémica).

TABLA 13.39.1: CARACTERÍSTICA VS ÚLCERA VENOSA

| CARACTERÍSTICA   | ÚLCERA VENOSA                          | ÚLCERA ARTERIAL                           |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dolor            | Habitualmente indolora                 | Muy dolorosa                              |
| Ubicación        | Región del maléolo interno             | Maléolo externo, dedos, puntos de presión |
| Color            | Violáceo / Eritematoso (estasis)       | Pálida / Necrótica                        |
| Pulsos           | Presentes                              | Ausentes o disminuidos                    |
| Piel circundante | Lipodermatoesclerosis, hiperpigmentada | Fría, atrófica, sin vello                 |

Manejo de la Insuficiencia Venosa

El tratamiento inicial es mayoritariamente **no invasivo** y conservador, enfocado en mejorar el retorno venoso.

1. Manejo Conservador (No quirúrgico)

- **Compresión elástica:** Es el pilar del tratamiento. El uso de medias de compresión graduada o vendas elásticas ayuda a reducir el diámetro venoso y mejorar la función valvular. - **Ejercicio físico:** Actividades que fortalezcan la musculatura de las piernas (bomba muscular de la pantorrilla), como caminar. - **Elevación de extremidades:** Mantener las piernas elevadas sobre el nivel del corazón durante periodos de descanso. - **Cuidado de úlceras:** Curaciones avanzadas según el estado de la herida.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Las úlceras venosas **no requieren antibióticos de forma rutinaria**. Solo se indican si existen signos clínicos de sobreinfección (celulitis, exudado purulento, aumento de calor local o fiebre).

2. Manejo Invasivo y Quirúrgico

Se reserva para casos graves, sintomáticos o con complicaciones (como úlceras recalcitrantes o sangrado).

- **Ablación Venosa:** Procedimiento mínimamente invasivo mediante radiofrecuencia o láser endovascular para destruir las venas afectadas.
- **Tratamiento de Perforantes:** Ablación dirigida a las venas que comunican el sistema profundo con el superficial cuando estas presentan incompetencia.
- **Cirugía (Safenectomía):** Extirpación quirúrgica de la vena safena insuficiente. Se indica cuando las técnicas menos invasivas fallan o no están disponibles.

Complicaciones Agudas: Varicorragia

La **varicorragia** es el sangrado espontáneo o traumático de una vena varicosa. Aunque puede ser alarmante por el volumen de sangre, su manejo inicial es sencillo.

- **Compresión externa:** Es la medida más importante. Aplicar presión directa sobre el punto de sangrado.
- **Elevación de la extremidad:** Reduce la presión hidrostática inmediatamente.
- **Sutura:** Si la compresión no es suficiente, se puede realizar una sutura simple del punto sangrante.
- **Cirugía de urgencia:** En casos excepcionales donde no se logra hemostasia, se procede a la ligadura de la safena o safenectomía.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Ante una **varicorragia**, lo primero es la presión directa y elevar la pierna. Nunca aplicar torniquetes proximales que no compriman el sistema arterial, ya que esto podría aumentar la presión venosa y empeorar el sangrado.

Consideraciones Estéticas

Muchos pacientes consultan por la apariencia de las várices o telangiectasias sin presentar síntomas de insuficiencia venosa funcional. - Se deben evaluar los riesgos y beneficios de cualquier intervención (escleroterapia, láser). - El manejo puede variar desde el uso de medias de compresión hasta procedimientos de ablación o cirugía, dependiendo de la gravedad estética y la autopercepción del paciente, siempre tras un consentimiento informado adecuado. **Insuficiencia Cardíaca | Trombosis Venosa Profunda | Hipertensión Arterial**

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 58 años con antecedente de várices de larga evolución consulta por una lesión ulcerada en maléolo interno izquierdo, de color violáceo, indolora, con piel circundante engrosada e hiperpigmentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Insuficiencia Venosa y Várices. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- El diagnóstico de insuficiencia venosa es clínico: várices, telangiectasias, edema crónico
- Edema agudo asimétrico obliga a descartar TVP antes de asumir insuficiencia venosa
- Úlceras venosas: indoloras, violáceas, maléolo interno, con lipodermatoesclerosis
- Úlceras arteriales: dolorosas, pálidas, maléolo externo (diagnóstico diferencial clave)
- Manejo inicial conservador: vendas elásticas, ejercicio, elevación de extremidades
- No requiere antibióticos salvo sobreinfección de úlceras
- Casos graves: ablación venosa (radiofrecuencia/catéter) o cirugía (safenectomía)
- Sangrado varicoso: compresión externa como primera medida

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INSUFICIENCIA VENOSA Y VÁRICES)****PREGUNTA 1**

Mujer de 58 años con antecedente de várices de larga evolución consulta por una lesión ulcerada en maléolo interno izquierdo, de color violáceo, indolora, con piel circundante engrosada e hiperpigmentada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Úlcera arterial por enfermedad arterial periférica
- B)** Úlcera venosa por insuficiencia venosa crónica
- C)** Celulitis necrotizante
- D)** Úlcera por pie diabético
- E)** Melanoma ulcerado

**PREGUNTA 2**

Paciente de 65 años con insuficiencia venosa crónica leve, sin úlceras, con várices moderadas y edema vespertino bilateral. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado?

- A)** Safenectomía bilateral electiva
- B)** Ablación venosa con radiofrecuencia
- C)** Medias compresivas, ejercicio y elevación de extremidades
- D)** Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular
- E)** Antibióticos profilácticos orales

**PREGUNTA 3**

Paciente con várices conocidas se golpea la pierna y presenta sangrado activo por una várice rota. ¿Cuál es la medida terapéutica inmediata más adecuada?

- A)** Ligadura quirúrgica urgente de la safena
- B)** Compresión externa directa sobre el sitio de sangrado
- C)** Torniquete proximal al sitio de sangrado
- D)** Ablación venosa con radiofrecuencia de urgencia
- E)** Sutura inmediata en pabellón

**RESUMEN: INSUFICIENCIA VENOSA Y VÁRICES**

El síndrome de insuficiencia venosa de extremidades inferiores es una patología de alta frecuencia y fácil diagnóstico clínico. Se manifiesta con venas dilatadas y tortuosas (várices), telangiectasias venosas de aspecto violáceo, y edema crónico de extremidades inferiores que puede ser simétrico o asimétrico. Es fundamental recordar que un edema de instalación aguda y asimétrica obliga a descartar TVP. Las úlceras varicosas o venosas tienen características específicas que las diferencian de las arteriales: son indoloras (vs. dolorosas), de color violáceo (vs. pálidas), se localizan en el maléolo interno (vs. externo) y se asocian a cambios tróficos cutáneos con lipodermatoesclerosis (piel engrosada e hiperpigmentada). El manejo es inicialmente conservador con vendas elásticas o medias compresivas, ejercicio de fortalecimiento muscular de piernas para favorecer el retorno venoso, elevación de extremidades y curaciones de úlceras si las hay (sin antibióticos salvo sobreinfección). En casos graves con úlceras importantes o muchos síntomas, se puede realizar ablación venosa con radiofrecuencia o catéter endovascular, o ablación de venas perforantes insuficientes. Si esto falla, se recurre a cirugía (safenectomía). En caso de sangrado varicoso (espontáneo o por trauma), la primera medida es compresión externa. Si persiste, se sutura. Solo en casos refractarios se realiza ligadura o safenectomía quirúrgica. El manejo estético se evalúa caso a caso considerando riesgos y beneficios con el paciente.